СЕМИНАР «ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ИДЕЙ 2.0» · МИНТРУД РОССИИ · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25–27 АВГУСТА 2026

Сколько стоит достойная жизнь

Реформа психоневрологических интернатов: что известно о ценах, что доказано за рубежом, что уже делают российские регионы и какой объём услуг можно купить на имеющиеся деньги.

Доклад для руководителей организаций социального обслуживания и региональных министров.

Версия 3, октябрь 2026. Переработана и расширена: проверены ключевые цифры, пересчитан калькулятор, добавлены данные 2023–2026 годов. Список исправлений — в приложении Б. У каждой цифры указан статус и источник.

Содержание

Как читать доклад · что изменилось в версии 3

Резюме · для министра, для директора

Часть 1. О ком и о чём: кто живёт в ПНИ и что такое сопровождаемое проживание

Часть 2. Сколько это стоит в России: данные и их границы

Часть 3. Что мировые исследования говорят о деньгах

Часть 4. Страны: Германия, Англия, Нидерланды, Япония и Корея, Италия, Финляндия, Дания, Бразилия

Часть 5. Провалы и их российские версии

Часть 6. Россия 2016–2026: закон, цифры, барьеры, регионы

Часть 7. Калькулятор: сколько услуг на 1 млн рублей

Часть 8. План региона и вопросы к самим себе

Приложения. А — глоссарий · Б — журнал исправлений · В — что не удалось проверить · Г — источники · Д — как повторить расчёты

ВВОДНАЯ

Как читать доклад

Доклад написан для людей, которые решают, на что тратить деньги в системе социального обслуживания: директоров ПНИ и региональных министров. Он отвечает на три вопроса. Сколько стоит содержание человека в разных форматах. Что показал зарубежный опыт. Что из этого применимо в России сейчас.

Как отмечены цифры

Метка	Что значит
без метки	Цифра проверена в этой версии по публикации или по документу. Источник указан цифрой в квадратных скобках и приведён в приложении Г.
†	Цифра перенесена из прежней версии доклада вместе со ссылкой на источник. В этой версии первоисточник не открывался. Перед публичным выступлением её стоит сверить.
«оценка»	Расчёт автора на основе проверенных данных и допущений. Допущения названы рядом. В приложении Д есть скрипт, который пересчитывает всё заново.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ВЕРСИИ 3

Главное исправление. В прежней версии цифры «8–24 тыс. ₽ в месяц в ПНИ» и «2–6 тыс. ₽ при сопровождаемом проживании» были представлены как стоимость содержания, и из них следовал вывод «сопровождаемое проживание дешевле в 4 раза». Проверка показала, что по описанию проекта «Если быть точным» это капитальные затраты на строительство и реновацию. Текущие расходы по тому же исследованию ВШЭ такие: ПНИ — **44,8 тыс. ₽**, проекты сопровождаемого проживания — **52,9 тыс. ₽** в месяц на человека [1][5][6]. Разница небольшая и в другую сторону.

Поэтому пересчитан калькулятор (часть 7), сняты расчёты «экономия 35–38 %» и обновлены выводы. Доказанным остаётся другое: качество жизни при сопровождаемом проживании заметно выше при сопоставимых деньгах. Это тоже аргумент, но другой, чем «дешевле».

Остальное: обновлены число жителей ПНИ, правовая рамка, события 2023–2026 годов; убраны региональные кейсы, которые не удалось подтвердить (приложение В); добавлена доказательная база по деинституционализации; текст сокращён и очищен от лозунгов.

РЕЗЮМЕ

Главное на двух страницах

Для министра: семь тезисов

1. **В ПНИ сегодня около 139 тысяч человек в 466 учреждениях** (2024). Пик был в 2018 году — 161 тысяча. Интернаты в среднем рассчитаны на 289 мест, заполнены на 98,6 %, в очереди около 2,8 тысячи человек [1].
2. **Месяц в ПНИ стоит в среднем 44,8 тыс. ₽, в проектах сопровождаемого проживания — 52,9 тыс. ₽** (в Москве — 111,9) по исследованию ВШЭ [5][6]. Реформа не является способом сэкономить. Она способ получить за близкие деньги другое качество жизни: индекс качества жизни по критериям ВОЗ — 76,9 балла против 56,9 [1][5].
3. **Мировые исследования не подтверждают лозунг «деинституционализация всегда дешевле».** Европейское исследование DECLOC (2007) пришло к выводу: сообщество не дороже учреждения при сопоставимых потребностях и качестве, а дешёвые учреждения почти всегда дают низкое качество. Систематический обзор 2019 года нашёл всего два сопоставимых исследования с противоположными результатами [16][17].
4. **Деньги нужны на переход.** Пока старые места работают, а новые квартиры уже оплачены, платить приходится дважды. Без «переходного фонда» реформы останавливаются или откатываются [16].
5. **Охват сопровождаемого проживания остаётся малым.** Минтруд называет около 7 тысяч человек (2024), независимые аналитики — не более 1,8 тысячи на постоянном проживании: три четверти участников живут в учебных квартирах, часто на территории ПНИ [1][4]. Потенциал по оценке Минтруда — до 45 % жителей, то есть около 63 тысяч человек.
6. **Главные барьеры — не бюджет.** 74 % жителей признаны недееспособными, их опекун обычно директор интерната. Закон о распределённой опеке Госдума отклонила в феврале 2025 года [3][13]. Жильё, кадры и подушевое финансирование идут следом.
7. **Есть риск реформы только на бумаге.** В 41 регионе ПНИ переименованы, при этом строятся новые крупные здания [1][3][32]. Критерий успеха — число людей, живущих вне интерната, и размер групп (в среднем 7–8 против рекомендованных Минтрудом 3–4).

Для директора: шесть тезисов

1. **Начните с обследования своих жителей.** В Нижегородской области у каждого пятого из 350 обследованных потребность не превышала 12 часов сопровождения в неделю [8]. Для вашего интерната эта доля неизвестна, пока вы её не измерили.
2. **Считайте в часах, а не в местах.** На 1 млн ₽ в год можно купить 1,9 места в ПНИ или от 1 700 до 2 900 часов сопровождения (при цене часа 350–600 ₽, это допущение). Это и есть ответ на вопрос «какой объём услуг» (часть 7).
3. **Сопровождение может быть дешевле места в ПНИ только при лёгкой потребности.** Для человека, которому нужно круглосуточное присутствие, сопровождаемое проживание

стоит столько же или больше. Планируйте людей по когортам, а не «всех в квартиры» (часть 7).

4. **Размер группы — это качество.** Минтруд рекомендует 3–4 человека, в российской практике в среднем 7–8 [4]. Квартира на 8 человек — малая форма по названию.
5. **Открытость защищает людей лучше проверок.** Скандалы в Уинтербоурн-Вью (Англия) и на Леросе (Греция) возникли в закрытых учреждениях, где никто снаружи не видел, что происходит. В 2023 году в петербургском ПНИ № 10 умерли семь человек с тяжёлыми нарушениями, причиной названо истощение из-за нехватки ухода и персонала [1].
6. **Не сокращайте то, что удерживает человека вне учреждения.** Опыт Скандинавии (часть 5): когда экономили на лёгкой помощи, люди возвращались в дорогие места.

ЧАСТЬ 1

О ком и о чём

1.1. Кто живёт в ПНИ

139 тыс.
человек в 466 ПНИ, 2024. Пик 2018 года — 161 тыс. [1]

74 %
признаны недееспособными (2022); опекун — обычно интернат [1][3]

65 %
старше 45 лет; в среднем по России — 43 % [1]

11 %
постоянно лежачие (2024) [1]

Цифры о числе жителей расходятся, потому что считают по-разному. «Если быть точным» по данным Минтруда насчитал 139 тысяч в ПНИ. Пресс-служба Минтруда сообщила «Ведомостям», что во всех отделениях для людей с ментальными нарушениями, включая отделения внутри других организаций, живёт более 174 тысяч человек и что число практически не менялось в 2022–2025 годах [2]. Число самих ПНИ снизилось с 536 в 2022 году до 466 в 2024-м, но авторы исследования и представители НКО связывают это в основном с объединением и переименованием учреждений, а не с закрытием [1][2]. Резкое падение численности на 26 тысяч (16 %) в 2023 году авторы не смогли объяснить и допускают смену формата отчётности [1].

Ещё несколько фактов из того же исследования [1]: 64 % жителей имеют вторую группу инвалидности и 31 % — первую; в 2022 году 98,6 % мест были заняты; в среднем интернат рассчитан на 289 мест (эксперты называют оптимальным размером 20–50), а самые крупные — около тысячи.

Важно, что ПНИ — не медицинская организация. Больница лечит и выписывает. Интернат организует жизнь на годы: проживание, питание, помощь в быту, занятость. Поэтому доклад говорит о социальном обслуживании, а не о психиатрии. Это та же задача, которую во всём мире решают в рамках долговременного ухода (long-term care).

1.2. Что такое сопровождаемое проживание

Это форма поддержки, при которой человек живёт в обычном жилье, один или в небольшой группе, а специалисты помогают ему по индивидуальному плану: от нескольких часов в неделю до круглосуточного присутствия. Понятие введено Федеральным законом от 28.04.2023 № 137-ФЗ как статья 9.1 закона «О социальной защите инвалидов» и относится к инвалидам старше 18 лет, которые без посторонней помощи не могут вести самостоятельную жизнь [11]. Порядок организации утверждён постановлением Правительства № 910 от 03.07.2024 [11], методические рекомендации — приказом Минтруда № 85 от 25.02.2025 [12].

> ЧТО СТОИТ РАЗЛИЧАТЬ
>
> **Учебное сопровождаемое проживание** — временное обучение навыкам, обычно в квартире на территории ПНИ или НКО. **Постоянное сопровождаемое проживание** — человек живёт вне интерната. В официальной статистике Минтруда учитываются оба вида (около 7 тысяч человек в 2024 году), в независимой оценке «Если быть точным» постоянное проживание — не более 1,8 тысячи человек в 214 квартирах [1][4]. На начало 2024 года 74 % участников программы жили в учебных квартирах [4].

1.3. Четыре единицы заботы

Разговоры об «объёме услуг» часто идут мимо друг друга, потому что объём измеряют разными единицами. У каждой своя цена и своё назначение.

Таблица 1.1. Единицы заботы

Единица	Что покупают	Кому подходит	Ориентир цены
Койка	Лечение, наблюдение врача в остром состоянии	Обострение, кризис; недели, не годы	Койко-день психиатрической больницы по региональным прейскурантам 1 100–4 840 ₽ †
Место	Проживание, питание, уход круглосуточно	Тяжёлая зависимость от помощи, нет жилья и поддержки	ПНИ: в среднем 44,8 тыс. ₽/мес [5]; диапазон оценок 50–120 тыс. ₽ [7]
Час	Помощь по дому, сопровождение, занятость — по потребности	Живёт дома или в квартире, нужна поддержка	350–600 ₽ за час (оценка, допущение; замените своим тарифом)
Квартира с сопровождением	Своё жильё и помощь по индивидуальному плану	Часть жителей ПНИ после обучения и при поддержке	52,9 тыс. ₽/мес в среднем по проектам; в Москве 111,9 [5] [6]

Мировая тенденция — двигаться по таблице снизу вверх по самостоятельности: от койки к месту, от места к часам и к квартире. Но это не значит, что каждая следующая единица дешевле. Цена зависит от того, сколько помощи нужно конкретному человеку, и это главный вывод части 2.

1.4. Как сегодня платят за место

Житель ПНИ вносит плату за стационарное обслуживание. Предельный размер — до 75 % среднедушевого дохода получателя (статья 31 Федерального закона № 442-ФЗ; формулировка в этой версии с текстом закона не сверялась). На практике у большинства жителей основной доход — пенсия, поэтому говорят «75 % пенсии». Человеку остаётся оставшаяся четверть. По сообщению сайта pnp.ru, заработная плата работающих в

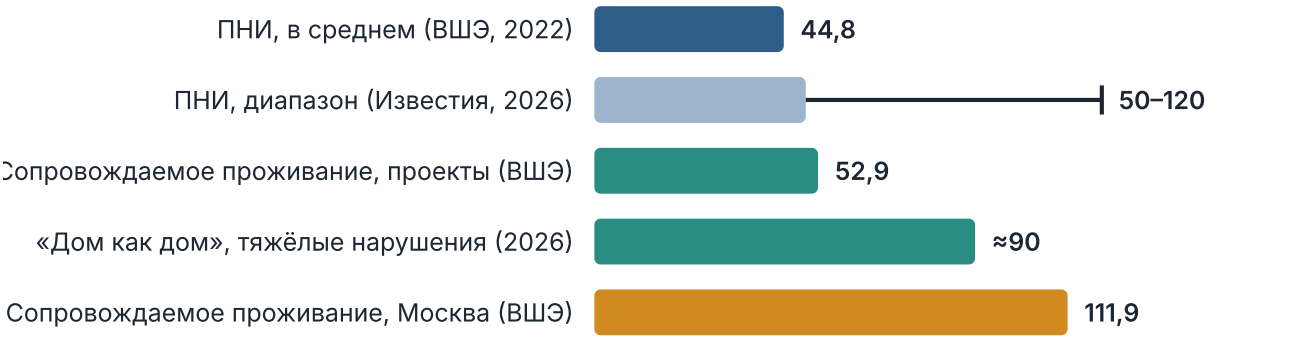
интернатах инвалидов больше не учитывается при расчёте среднедушевого дохода [14]; дата и номер постановления в источнике не указаны, их стоит уточнить до публичного использования.

ЧАСТЬ 2

Сколько это стоит в России: данные и их границы

2.1. Что известно

Единой официальной методики расчёта стоимости месяца в ПНИ на одного человека нет: на это указывают и аналитики, и авторы публикаций [1][6]. Поэтому в разговоре о деньгах нужно держать в голове сразу несколько оценок, которые получены разным способом.



Текущие расходы на одного человека в месяц, тыс. ₽. Методики

Рисунок 2.1. Оценки текущих расходов на одного человека в месяц, тыс. ₽ [5][6][7]. Источники считали по-разному, поэтому бары нельзя читать как прямое сравнение.

Таблица 2.1. Оценки стоимости, тыс. ₽ в месяц на человека

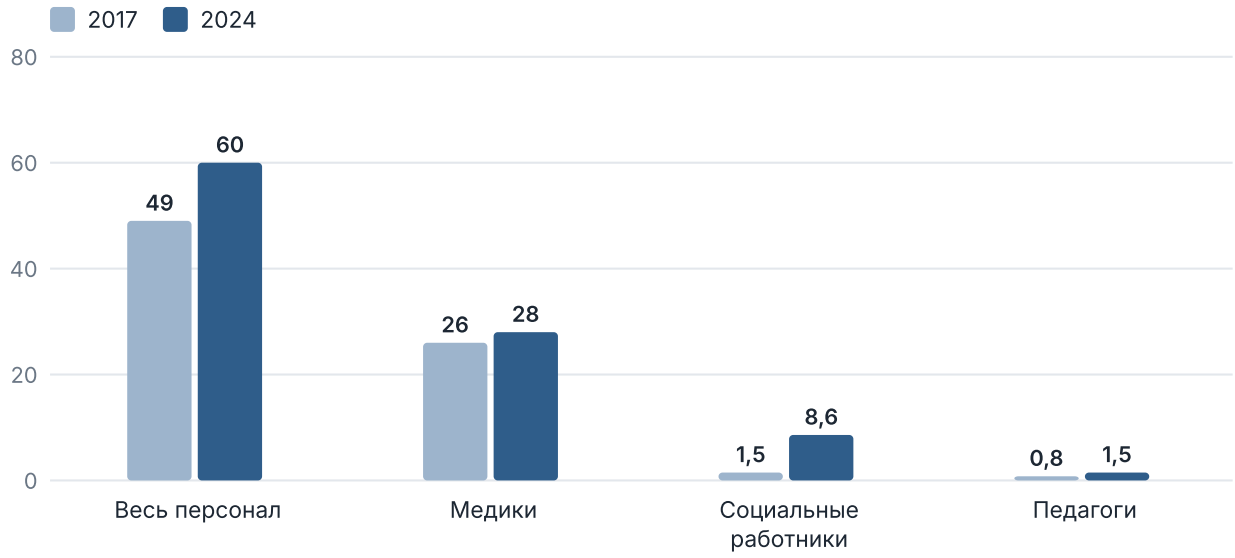
Оценка	Значение	Источник и оговорки
ПНИ, среднее	44,8	НИУ ВШЭ при поддержке Фонда Потанина, публикация 22.12.2022 [5][6]. Выборка и методика в публикациях не описаны.
Проекты сопровождаемого проживания, среднее	52,9	То же исследование. В обследованных проектах большинству подопечных нужно круглосуточное сопровождение [6].
То же, Москва	111,9	То же исследование [6].
ПНИ, диапазон	50–120	Исследования 2021–2022 годов в пересказе «Известий» (2026) [7].
Дом сопровождаемого проживания «Дом как дом» (Ярославская область)	≈90	Руководитель благотворительной организации в «Известиях», 2026; при полной загрузке, для людей с тяжёлыми нарушениями. Ассистенты стоят 15 млн ₽ в год [7].

2.2. Почему эти цифры нельзя просто сравнить

- **Разные люди.** В обследованных проектах сопровождаемого проживания большинству нужно круглосуточное сопровождение [6]. В среднем ПНИ живут люди с разными потребностями, включая тех, кому нужно меньше. Цена человека с лёгкой потребностью и цена человека с тяжёлой — разные вещи, а среднее их скрывает.
- **Разный состав затрат.** В цену места входят питание, медицина, коммунальные услуги, администрация. В цену сопровождения иногда входит только оплата работы специалистов, а жильё и еда оплачиваются отдельно из пенсии человека.
- **Капитальные и текущие затраты.** По пересказу «Если быть точным», диапазоны 8–24 тыс. ₽ (строительство или реновация ПНИ) и 2–6 тыс. ₽ (сопровождаемое проживание с покупкой квартир) в месяц на человека — это капитальные затраты, а не текущие [1]. В публикациях АСИ и «Милосердия» этих цифр нет, поэтому первоисточник — отчёт ВШЭ — стоит открыть и сверить.
- **Москва.** Московская цена более чем вдвое выше средней по проектам. Региону без московской зарплаты и аренды стоимость будет ближе к среднему значению.

2.3. Что стоит за разницей в персонале

По данным ВШЭ, на одного штатного социального работника в ПНИ приходится в среднем 34,6 подопечных, в сопровождаемом проживании, как правило, один сотрудник на одного подопечного [5]. «Если быть точным» показывает, как менялась обеспеченность персоналом в ПНИ: с 49 до 60 работников на 100 жителей с 2017 по 2024 год, социальных работников стало почти в шесть раз больше (с 1,5 до 8,6 на 100 жителей) [1]. Три четверти основного персонала по-прежнему медики. Оговорка: Минтруд считает ставки, а не людей, поэтому рост может быть завышен [1].



Работников на 100 жителей ПНИ. «Если быть точным» по данным Минтруда; считаются ставки, а не люди.

Рисунок 2.2. Персонал ПНИ на 100 жителей, 2017 и 2024 годы [1].

2.4. Что с качеством

ВШЭ измеряла качество жизни по критериям ВОЗ. Интегральный индекс — 76,9 балла из 100 в сопровождаемом проживании и 56,9 в ПНИ [1][5][6]. Наибольшая разница — в социальном благополучии (с 44,3 до 84,7 балла) и здоровье (с 69,1 до 85,2); безопасность почти не изменилась (с 51,6 до 57,1) [5]. Выборка и методика в публикациях не раскрыты, оценка сделана на проектах НКО, а не на случайной выборке. К выводам надо относиться как к сильному сигналу, но не как к окончательному доказательству.



Индекс качества жизни по критериям ВОЗ, баллы из 100. НИУ ВШЭ, 2022.

Рисунок 2.3. Качество жизни по критериям ВОЗ, баллы. НИУ ВШЭ, 2022 [5].

2.5. Цена «ничего не менять»

ВШЭ оценила, что довести ПНИ до того же уровня качества потребовало бы увеличить текущие расходы в 2–3 раза и вложить не менее 200–300 млрд ₽ в реновацию [1][5]. Если разделить на 139 тысяч жителей, получается 1,4–2,2 млн ₽ на человека (расчёт автора). Для сравнения: однокомнатная квартира, которую делят три-четыре человека, в большинстве регионов обходится дешевле на каждого. Это не доказательство, но порядок величин показывает: «сохранение» не бесплатно.

> **ВЫВОД ЧАСТИ 2**
>
> Проверенные данные не позволяют говорить, что сопровождаемое проживание дешевле ПНИ. Они позволяют говорить: (1) цена близка; (2) качество выше; (3) для людей с лёгкой потребностью сопровождение может оказаться дешевле, для людей с круглосуточной потребностью — дороже; (4) вложения в «подтягивание» ПНИ до того же качества сопоставимы по масштабу с вложениями в квартиры. Эти выводы и лежат в основе калькулятора (часть 7).

ЧАСТЬ 3

Что мировые исследования говорят о деньгах

3.1. Европейское исследование DECLOC

Самое систематическое исследование по теме — DECLOC («Деинституционализация и жизнь в сообществе: результаты и затраты»), проведённое по заказу Европейской комиссии центром Тизард Кентского университета и партнёрами из нескольких стран. Отчёт Мансела, Кнаппа, Бидл-Браун и Бичама опубликован в 2007 году, он охватывал 28 стран [16]. Основные выводы:

- В хорошей системе поддержка людей с серьёзными нарушениями стоит дорого вне зависимости от места жизни. Не стоит ожидать низких затрат в сообществе только потому, что заменяемые учреждения кажутся дешёвыми. **Дешёвые учреждения почти всегда дают низкое качество.**
- Нет данных, что сообщество по своей природе дороже учреждения, если сравнивать при **сопоставимых потребностях жителей и качестве**. При правильной организации сообщество даёт лучшие результаты.
- Если учреждение недорогое, то перевод людей с лёгкими потребностями обычно обходится примерно в те же деньги или дешевле при том же или более высоком качестве. Людям с тяжёлыми потребностями в сообществе нужно больше денег, но качество выше. Директорам не стоит рассчитывать, что стоимость учреждения удастся сохранить низкой.
- Сравнивать затраты между системами без учёта потребностей людей и результатов — методическая ошибка, которая рискует привести к опасному недофинансированию.
- Закрытие учреждения редко приносит много денег сразу: здания старые, земля не всегда востребована, выручка от продажи появляется только после полного закрытия. Нужны «горбатые» расходы на старте и **двойное финансирование** (старые и новые службы параллельно) на несколько лет.
- Помогает ограждение бюджета: деньги закрываемого учреждения полезно защитить и направить на развитие услуг в сообществе.

3.2. Что показал систематический обзор

В 2019 году в журнале BMJ Open вышел систематический обзор «Влияние деинституционализации для взрослых с интеллектуальными нарушениями на затраты» (May и соавторы). Он нашёл всего два подходящих исследования, обе британские когортные работы 1980–1990-х годов о людях, покидавших больницы длительного пребывания. Результаты противоположны: в одной работе средние затраты в сообществе были ниже (без проверки значимости), в другой — выше на 1, 5 и 12-й год, статистически значимо. Вывод авторов: «забота в сообществе не однозначно дешевле» и данные неубедительны, нужны современные исследования [17].

> **ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ НАС**
>
> Нет научной основы обещать министру экономию «в разы». Есть научная основа утверждать: при сопоставимом качестве сообщество не дороже, дешёвые учреждения дают низкое качество, а выигрыш — в результатах для человека. Это честная позиция, и она устойчива к проверке.

3.3. Как тратят в мире

ОЭСР измеряет расходы на долговременный уход, то есть всё, что общество тратит на помощь людям, которые не справляются с повседневной жизнью. В 2021 году в среднем по ОЭСР это около 1,8 % ВВП; самые высокие значения — Нидерланды (4,4 %), Норвегия (3,5 %), Швеция (3,4 %), Дания (3,2 %); Греция, Польша и Латвия тратят около 0,5 % или меньше [19]. Доля долговременного ухода в расходах на здравоохранение — в среднем 13 %, в странах с развитыми системами четверть и больше [19].



Расходы на долговременный уход, % ВВП. ОЭСР, Health at a Glance

Рисунок 3.1. Расходы на долговременный уход, % ВВП [19][28]. Россия — авторская оценка версии 2 (†, не пересчитывалась): в российской статистике такой строки нет, поэтому сравнение приблизительно.

Для России отдельной оценки в ОЭСР нет. В версии 2 была дана авторская оценка 0,1–0,2 % ВВП† (бюджетные расходы на стационарное и надомное социальное обслуживание, расчёт снизу вверх). В этой версии она не пересчитывалась и показана на графике только как ориентир. Отдельно стоят расходы системы долговременного ухода (СДУ) для пожилых и инвалидов: в 2026 году на неё выделено 31,5 млрд ₽, в рамках федерального проекта «Старшее поколение» заложено 362 млрд ₽, из них 307 млрд — на организацию ухода [9] [10].

3.4. Международные обязательства

Комитет ООН по правам инвалидов в 2022 году принял руководящие принципы по деинституционализации, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Они дополняют Замечание общего порядка № 5 (2017) по статье 19 Конвенции о праве жить самостоятельно и быть включённым в общество и указывают, что осуществление прав по статье 19 нельзя приостанавливать даже в чрезвычайной ситуации [29]. Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов в 2012 году.

3.5. Предупреждение: деньги Евросоюза не гарантируют реформу

Европейские организации, включая ENIL и Европейскую коалицию за жизнь в сообществе, неоднократно показывали, что структурные фонды ЕС шли на содержание и строительство учреждений. Доклад 2010 года «Wasted time, wasted money, wasted lives…» рассматривал Венгрию и Румынию; брифинг ENIL 2018 года по данным 18 стран и теневой доклад 2025 года фиксируют, что средства всё ещё идут в большие учреждения, малые групповые дома и мастерские вместо услуг в сообществе [18]. Для нас урок практический: источник денег не заменяет правил, на что их можно тратить.

ЧАСТЬ 4

Страны: что известно и чего мы не знаем

В каждой карточке три блока: что подтверждено, чего не хватает для выводов, что можно взять России. Сумма в национальной валюте указана так, как её публикует источник.

4.1. Германия: страхование долговременного ухода

Что известно. Отдельное обязательное страхование ухода (Pflegeversicherung) действует с 1995 года. С 1 января 2025 года взнос — 3,6 % от облагаемого дохода, для бездетных 4,2 % [21]. Расходы в 2025 году выросли на 8,2 % до 73,8 млрд €, поступления от взносов — 72,5 млрд €; дефицит удалось избежать только за счёт федерального кредита 500 млн €. В 2024 году дефицит составил 1,54 млрд €. На 2026 год планируются расходы около 79 млрд € при взносах 75,3 млрд €; без нового кредита 3,2 млрд € результат был бы минус 4,4 млрд € [20]. В прежней версии стояла цифра 63,3 млрд € за 2024 год†. Из роста на 8,2 % следует, что в показателе GKV-Spitzenverband расходы 2024 года составляли около 68,2 млрд €, то есть показатель шире, и две цифры нельзя ставить рядом. Получателей около 6 млн человек [20].

По прежней версии, средние расходы на человека в год — 9 172 € при уходе на дому и 26 978 € в стационаре†; пособие Pflegegeld (деньги семье, которая ухаживает сама) составляло 27 % расходов†.

Чего не хватает. Система хронически дефицитна, резервы тают. Без федеральных кредитов она не сводится.

ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ Идея не в страховке, а в трёх принципах: уход как отдельный бюджетный риск, который виден и считается; пять ступеней потребности (Pflegegrade) определяют пакет помощи; семья получает деньги за уход, а не только «обязанность». Региональный аналог пособия семье, забравшей человека из ПНИ, нужно считать на своих данных; в этой версии не приводится цена, потому что нет подтверждённых цифр.

4.2. Англия: муниципалитеты, персональные бюджеты

Что известно. Общие расходы на взрослое социальное обслуживание в Англии в 2024/25 году составили 34,5 млрд £ (+7,9 % в текущих ценах, +4,1 % в реальных). Валовые текущие расходы местных властей — 29,4 млрд £, из них 80 % (23,6 млрд £) — долговременная поддержка. Недельная цена места в доме ухода выросла на 7 % до 1 185,55 £ [22]. Взносы получателей выросли на 14 % и стали главным источником доходов местных властей после основного финансирования [22]. Отчёт теперь публикует Министерство здравоохранения и социальной защиты (DHSC), а не NHS England, поэтому данные нельзя напрямую сравнивать с прежними годами [22].

По прежней версии†: сопровождаемое жильё стоит около 1 569 £ в неделю (232 жильё + 1 337 помощь), место в доме ухода — 1 760 £, лечебное отделение для людей с расстройствами развития — 3 500 £. Источники — Mencap и Housing LIN.

Чего не хватает. Система хронически недофинансирована, реформа софинансирования отменена в 2025 году†.

ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ Англия отдельно считает сопровождаемое проживание и прямые выплаты получателю. То, что не посчитано, не масштабируется. В российском регионе первой задачей будет завести отдельную строку расходов на сопровождаемое проживание и учебные квартиры.

4.3. Нидерланды: Хогевейк и городская модель

Что известно. Хогевейк в Веспе (рядом с Амстердамом) — «деревня» для людей с тяжёлой деменцией, открыта в 2009 году: 23 дома, около 150 жителей†, дома по «стилям жизни» (подбор по укладу, а не по диагнозу). Оператор Vivium заявляет, что деревня финансируется по тому же тарифу, что и обычные дома ухода.

Чего не хватает. Канадское агентство CADTH не нашло опубликованных оценок самого Хогевейка и отметило, что объективных доказательств улучшения клинических результатов и качества жизни, а также данных об эффективности затрат недостаточно; воспроизведение модели потребует дополнительных капитальных затрат из-за большой площади [23]. Поэтому утверждения «жители активнее и получают меньше лекарств», которые были в прежней версии доклада, сняты как недоказанные.

ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ Идеи, которые не требуют денег: подбор соседей по укладу жизни, а не по диагнозу; малые группы; персонал без белых халатов; доступ к обычной жизни (магазин, кухня, двор). Строить «деревню» не нужно.

4.4. Япония и Корея: страхование ухода и скорость

Япония. Страхование долговременного ухода (LTCI) введено в 2000 году. Расходы в 2022 финансовом году составили 11,2 трлн иен† (источник — Nippon.com со ссылкой на Минздрав). Средняя длительность психиатрической госпитализации уменьшилась с примерно 500 дней в 1990 году до 266 дней в 2018 году по статистике Минздрава; метод расчёта критикуют, так что международное сравнение условно [27]. Коек в психиатрии на 100 тысяч жителей около 267 при среднем по ОЭСР около 66 [27].

Корея. Страхование долговременного ухода введено в 2008 году. К 2019 году суммарные расходы достигли около 1,0–1,1 % ВВП (в зависимости от источника), расходы по страхованию выросли в среднем на 15,2 % в год в 2009–2018 годах, доля людей 65+, охваченных услугами, поднялась с 3,9 % (2008) до 8,4 % (2018) [28]. В прежней версии было утверждено, что Корея за 13 лет выросла с 0,1 до 1 % ВВП†; данные по 2008 году в этой версии не подтверждены.

ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ У Кореи страхование ввели сразу в масштабе страны, без полувековой подготовки. Но у Кореи иная демографическая и налоговая база. Для российских регионов практичнее взять из Японии кейс-менеджера (один специалист собирает пакет услуг) и сертификацию потребности вместо оценки по диагнозу.

4.5. Италия: Триест

Что известно. Закон 180 («закон Базальи», 1978) прекратил госпитализацию в старые психиатрические больницы; последняя больница закрыта к концу 1990-х†. Описания системы Триеста за 2006–2012 годы совпадают: на примерно 240 тысяч населения работают четыре центра психического здоровья, открытые круглосуточно; каждый обслуживает около 60 тысяч жителей, имеет 6–8 кроватей для временного пребывания; в больнице общего профиля — 6 кроватей, в основном для ночных экстренных случаев; около 45 мест в поддерживаемом жилье; штат — около 1 сотрудника на 1 000 жителей [30]. В 1971 году в психиатрической больнице было около 1 200 коек [30].

Чего не хватает. Свежих данных (2023–2024) в этой версии нет. Источники — обзоры 2006–2014 годов; один из них отмечает, что модель находится под угрозой, без уточнения [30]. Цифры о числе мест в защищённых резиденциях по Италии и числе социальных кооперативов в прежней версии не подтверждены и убраны (приложение В).

ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ Круглосуточный центр в районе, где можно остаться на несколько ночей в кризис, а не госпитализироваться в больницу за городом, снимает страх «а что, если обострение». Это тот же барьер, который регионы называют главным при выписке из ПНИ.

4.6. Финляндия: Housing First

Что известно. Housing First даёт постоянную квартиру без условий (трезвость, лечение), а поддержка прикладывается к адресу. Долговременная бездомность в Финляндии за 2008–2022 годы снизилась на 68 % [24]. В пилоте Министерства окружающей среды экономия составила около 14,98 тыс. € на человека в год†.

Что изменилось. Тренд развернулся. По данным ARA от 10.02.2025, в Финляндии насчитали 3 806 бездомных, на 377 больше, чем годом ранее — первый рост после 11 лет снижения. Число людей, ночующих на улице, в подъездах и ночлежках, выросло на 50 % до 694. Причины, названные городами: рост стоимости жизни, сокращение социальных выплат, высокие арендные ставки, вдвое урезанный бюджет консультаций по жилью. Правительственная программа «устранить долговременную бездомность к 2027 году» остаётся целью [24]. Прежнее утверждение «единственная страна ЕС, где бездомность сокращается» теперь неверно.

Оценка эффективности. Канадский рандомизированный эксперимент At Home/Chez Soi показал, что Housing First повышает стабильность жилья; затраты на программу по промежуточным отчётам компенсировались в среднем на 54 %, для группы с высокой потребностью — почти полностью (разные отчёты называют от 96 до 154 %). Вывод авторов: программа даёт значительную компенсацию затрат, но не всегда окупается полностью [25].

ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ Идея Housing First для ПНИ — жильё и сопровождение сразу, не «заслужи дисциплиной». Финский подход к расчёту — считать, во что обходится человек «внутри» и во что — снаружи, — годится для регионального Минфина, но, как показывает Канада, итоговая цифра зависит от того, откуда человек пришёл.

4.7. Дания и Скандинавия

Что известно. В 1987 году Дания приняла закон, по которому новые дома ухода строятся как отдельные квартиры (plejeboliger) с кухней, ванной и входной дверью. Жилец — наниматель с полной пенсией, платит аренду и сам решает, какие услуги покупать у дома† (источник — текст закона на retsinformation.dk). С 2015 года закреплён подход hverdagsrehabilitering — трёх-двенадцатинедельная интенсивная тренировка бытовых навыков вместо пассивной помощи†.

Чего не хватает. Датская система также сокращала лёгкую помощь. По Nuffield Trust (2025)†: охват домашним уходом людей 80+ упал с 43 % в 2008 году до 27 % в 2020; в Швеции доступность мест для 80+ упала с 20 % до 11 %, очередь выросла до 64 дней†. Разница в доступности между норвежскими муниципалитетами — от 32 % до 76 %†.

ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ Прежнее утверждение «датская норма» («пенсия — человеку») «снимает дилемму» снято. Передача пенсии человеку меняет, кто платит, и повышает самостоятельность, но не уменьшает полную стоимость жизни. Для региона это политический и правовой вопрос, а не экономия.

4.8. Бразилия: деньги за человеком

Что известно. Закон 10.216 (2001) запустил закрытие психиатрических больниц и развитие общинных служб (CAPS). Научные публикации подтверждают: койки в 1995–2005 годах сократились на 41 % (с 5,4 до 3,2 на 10 тысяч жителей); доля психиатрических госпитализаций в бюджете снизилась с 95,5 % до 49 %; с 2006 года внебольничные расходы превышают больничные; в конце 2010-х насчитывалось около 2,5 тысяч CAPS [26]. По обзору материалов конференции, доля внебольничных расходов достигла 79,39 % в 2013 году [26]. Цифры «24,8 % → 79,4 %» из прежней версии как рост 2002 → 2014 годов подтвердить не удалось (приложение В).

Чего не хватает. Расходы на душу населения по тому же исследованию сократились (с 2,66 до 1,95 долл.): реформа шла на ограниченных деньгах. Реформа неравномерна по регионам [26].

ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ Бразилия показывает, что структура бюджета может измениться без увеличения общей суммы. Для регионов это ориентир, а не обещание.

ЧАСТЬ 5

Провалы и их российские версии

Чужие провалы полезнее чужих успехов, потому что их можно использовать как список проверок.

5.1. США: закрыли больницы, не построили сообщество

По Treatment Advocacy Center, в 2014 году около 383 тысяч человек с тяжёлыми психическими расстройствами находились в тюрьмах и следственных изоляторах, примерно в десять раз больше, чем в оставшихся государственных психиатрических больницах†. Закон 1963 года обещал 1 500 общинных центров, построена меньше половины, финансирование сократили в 1980-е. Цифры «31 000 $ в год за тюрьму против 10 000 $ в сообществе» из прежней версии не подтверждены и убраны (приложение В). Урок: сначала альтернатива, потом выписка.

5.2. Англия: Уинтербоурн-Вью

31 мая 2011 года программа BBC Panorama показала скрытую съёмку из частной больницы для людей с расстройствами развития. 11 сотрудников были привлечены к ответственности, шестеро получили реальные сроки [31]. Оператор Castlebeck в сентябре 2013 года обанкротился [31]. Из 48 человек, живших в больнице, к июню 2014 года десять оставались в стационарах, остальные были в домах ухода, сопровождаемом жилье или собственных квартирах [31]. Программа Transforming Care по возврату людей домой шла годами: по материалам юридической фирмы Leigh Day, и в 2021 году сотни человек оставались в стационарах [31]. Главный урок: законов и денег было достаточно, не хватало локальных служб, жилья и внешнего взгляда внутрь закрытых учреждений.

5.3. Греция: Лерос

В 1989 году газета Observer назвала остров Лерос «европейской грязной тайной»: около 1 200 человек жили в бывших казармах†. Европейская комиссия выделяла средства на реформу с 1984 года, но заметных изменений не было. Реформа пошла только когда на остров приехала команда с методом (специалисты из Триеста) и несколько лет работала с жителями, персоналом и местной экономикой†. В 2009 году BBC нашла в греческой больнице Дромокраитион привязанных пациентов и две медсестры на 30 человек†. Урок: проектное финансирование без постоянной статьи бюджета откатывается.

5.4. Скандинавия: ошибка экономии на лёгком

См. 4.7: когда лёгкие услуги сократили, люди раньше времени переходили в более дорогие формы.

5.5. Российские версии этих ошибок

Риск	Что видно в России	Источник
Переименование вместо реформы	К концу 2025 года ПНИ переименованы как минимум в 41 регионе (первой была Москва, 2022). Эксперты считают это в основном внешним изменением.	[1][3]
Новые большие здания	Минтруд и Минстрой объявляли программу строительства современных домов престарелых и ПНИ на 40 млрд ₽ в рамках «Старшего поколения»; с 2025 года федеральные средства идут на строительство и реновацию региональных учреждений. Эксперты называют это препятствием реформе: деньги идут на крупные интернаты по старой модели.	[2][3][32]
Учебное проживание как конец пути	74 % участников программы — в учебных квартирах, часто на территории ПНИ. Часть возвращается в интернат.	[4]
Большие группы	Средняя группа в квартирах — 7–8 человек при рекомендации Минтруда 3–4.	[1][4]
Отказ по формальной причине	Регионы иногда отказывают в сопровождаемом проживании, ссылаясь на «нецелесообразность» жизни вне стационара; проекты для самых уязвимых в основном ведут НКО.	[4]
Неустойчивое финансирование	Услуга, которой нет в региональном перечне социальных услуг, не финансируется. Ленинградская область решила это отдельным перечнем из 14 услуг. НКО нужна стабильная финансовая база: при потере гранта услуги прерываются.	[8]
Недееспособность как стена	74 % жителей недееспособны, опекун — обычно интернат. Закон о распределённой опеке отклонён в 2025 году. Без этого выход из ПНИ зависит от решения директора.	[1][3][13]

ЧАСТЬ 6

Россия 2016–2026: закон, цифры, барьеры, регионы

6.1. Хронология

Год	Событие	Ист.
2016	Разработана первая дорожная карта реформы ПНИ	[1]
2017	Первые методические рекомендации Минтруда по сопровождаемому проживанию	[1][8]
2019	Субсидии регионам на сопровождаемое проживание в рамках «Доступной среды»	[8]
2020	Приказ Минтруда закрепил жизнь вне ПНИ как приоритет	[1]
2022	Пилот Минтруда в Нижегородской и Воронежской областях; исследование ВШЭ о стоимости и качестве	[5][8]
2023	№ 137-ФЗ от 28.04.2023: сопровождаемое проживание в законе о социальной защите инвалидов (статья 9.1). Приказ Минтруда № 606н от 28.07.2023 о порядке определения объёма услуг	[11]
2024	Постановление Правительства № 910 от 03.07.2024 об организации сопровождаемого проживания	[11]
Февраль 2025	Госдума отклонила законопроект о распределённой опеке	[13]
2025	Приказ Минтруда № 85 от 25.02.2025 — методические рекомендации; в силу с 1 марта 2025	[12]
2026	СДУ охватывает около 184 тысяч человек (11 % нуждающихся), цель на 2030 год — 30 %	[9] [10]

В источниках расходятся даты вступления статьи 9.1 в силу (1 сентября 2023 или 2024 года); для юридических целей нужно сверить текст на pravo.gov.ru [11].

6.2. Сколько людей реально вышло из интерната



Тысяч человек. «Если быть точным», Минтруд. 62,8 — расч

Рисунок 6.1. Жители ПНИ, потенциал перехода и фактический охват, тыс. человек [1][2][4].

Данные Минтруда о сопровождаемом проживании: около 7 тысяч человек в 2024 году (в 2,6–2,7 раза больше, чем в 2018-м), по итогам 2025 года — около 8 000 человек с инвалидностью, из них 6 400 с ментальными нарушениями [2][4]. Независимые аналитики насчитывают постоянное проживание не более чем у 1,8 тысячи человек (214 квартир, в среднем по 7–8 человек) [1][4]. Лидеры по развитию — Санкт-Петербург, Ленинградская и Свердловская области [4]. Минтруд называет передовыми регионами Санкт-Петербург, Пензенскую, Ленинградскую, Свердловскую, Псковскую, Челябинскую области и Якутию [1].

6.3. Региональные кейсы (проверенные)

Регион	Что сделано	Ист.
Нижегородская область	Обследовали 350 жителей ПНИ: у каждого пятого потребность не более 12 часов сопровождения в неделю. Создан специализированный дом на 11 человек. Двое бывших детей-сирот получили жильё и переехали в собственные квартиры. На 2025 год — ремонт ещё четырёх квартир и разработка стандартов услуг.	[8]
Ленинградская область	«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» сопровождает 150 человек с ментальной инвалидностью. Создан дополнительный перечень из 14 услуг, включая помощь в управлении финансами. Работодатель получает субсидию до 500 тыс. ₽ на специализированное рабочее место; наставникам платят стимулирующие выплаты до трёх месяцев.	[8]
Санкт-Петербург	По отчёту уполномоченного по правам человека за 2024 год, более 70 % индивидуальных программ реабилитации трудоспособных жителей бывших ПНИ нуждаются в пересмотре; выявлено 68 кандидатов на самостоятельное проживание с индивидуальным сопровождением и 48 — на групповое.	[4]
Свердловская область (Верх-Нейвинский)	Организация «Благое дело» (программа «Социополис») готовила к открытию дом сопровождаемого проживания на 7 человек в усадьбе 1880 года рядом со своими мастерскими. Сведений о пекарне, указанной в прежней версии, не найдено; статус дома после 2021 года не уточнён.	[15]
Ярославская область («Дом как дом»)	Благотворительный проект для людей с тяжёлыми нарушениями: около 90 тыс. ₽ в месяц на жителя при полной загрузке, 15 млн ₽ в год — ассистенты.	[7]
Якутия	Госкорпорация ВЭБ.РФ и организация ГАООРДИ планировали к концу 2024 года открыть отделение постоянного сопровождаемого проживания на 12 человек и сопровождение на дому ещё для 18. В республике около 1 100 человек с ментальными нарушениями живут в ПНИ или получают иную госпомощь. Это плановые показатели; итоги не проверены.	[33]

6.4. Система долговременного ухода (СДУ)

СДУ — отдельная федеральная система для пожилых и людей с инвалидностью, нуждающихся в уходе; не путать с сопровождаемым проживанием. В июне 2026 года, по данным Минтруда, она охватывает около 184 тысяч человек (11 % нуждающихся; годом ранее 10,5 %), в сельской местности — 45 тысяч; цель на 2030 год — 30 % (около 500 тысяч человек). В 2026 году на неё выделено 31,5 млрд ₽; порядок регулирует приказ Минтруда № 732 от 27.12.2024 [9][10]. Для темы доклада СДУ важна тем, что она создаёт то, чего не хватает при выходе из ПНИ: надомный уход и подготовленных ухаживающих. Какая часть жителей ПНИ реально использует СДУ, в доступных публикациях не указана.

6.5. Шесть барьеров

Барьер	Суть	Что делают в регионах и за рубежом
1. Недееспособность	74 % жителей недееспособны; опекун — директор. Без распределённой опеки человек зависим от интерната.	Ленинградская область: услуга «помощь в управлении финансами». Минтруд рекомендует работу по восстановлению статуса; в 2024 году число людей, восстановивших дееспособность из частично недееспособных, выросло примерно в 1,5 раза [2]. Предложение Центра лечебной педагогики — передавать функции опекунов организациям-поставщикам услуг [8].
2. Жильё	У человека нет квартиры, куда выписываться; квартиры, положенные детям-сиротам, нельзя использовать, пока человек в интернате.	Нижний Новгород: восстановление сиротских прав. Нужно законодательное решение о выделении таких площадей под сопровождаемое проживание [8].
3. Пенсия и плата	До 75 % дохода идёт на оплату места.	Решение федеральное; регион может подготовить расчёт и пилот. Влияет на самостоятельность и на то, кто платит, не на полную стоимость.
4. Финансирование «на место»	Бюджет считается по койкам; сократил места — потерял деньги.	Норматив «на человека с потребностью» вместо «на место» и перечень услуг, который включает сопровождение (опыт Ленобласти).
5. Кадры	Сопровождающих как профессии мало. Зарплаты социальных работников неконкурентны [9].	Обучение действующих сотрудников ПНИ, методика и тариф; кейс-менеджер (Япония).
6. Страх ответственности	«Что, если с человеком что-то случится вне стен?»	Круглосуточный центр кризисной поддержки в районе (Триест), поэтапный переход с учебной квартирой, понятный порядок действий при обострении.

ЧАСТЬ 7

Калькулятор: сколько услуг на 1 млн рублей

Калькулятор строится на двух проверенных входных данных (44,8 и 52,9 тыс. ₽ в месяц по ВШЭ) и на допущениях, которые названы отдельно. Допущения нужно заменить данными своего региона. В приложении Д есть скрипт, который пересчитывает всё при изменении исходных цифр.

7.1. Что можно купить на 1 млн ₽ в год

Таблица 7.1. Объём услуг на 1 млн ₽ в год

Единица	На 1 млн ₽	Основание
Место в ПНИ	1,9 человека	44,8 тыс. ₽ × 12 мес = 537,6 тыс. ₽ в год (ВШЭ)
Сопровождаемое проживание	1,6 человека	52,9 тыс. ₽ × 12 = 634,8 тыс. ₽ (ВШЭ)
Сопровождаемое проживание, Москва	0,7 человека	111,9 тыс. ₽ × 12 = 1 342,8 тыс. ₽ (ВШЭ)
Часы сопровождения	1 700–2 900 часов	Допущение: 350–600 ₽ за час. Это 32–55 часов в неделю в течение года, то есть около 3–5 человек с нагрузкой 12 часов в неделю

Объём услуг на деньги не определяется одной цифрой. Один и тот же миллион даёт два места или три-пять человек на лёгком сопровождении. Всё зависит от того, кому что нужно. Поэтому первый шаг — обследование.

7.2. Когда квартира с сопровождением дешевле места

Простая модель. Полная стоимость жизни в квартире = (часы в неделю × 52 ÷ 12 × цена часа) + жильё и быт. «Жильё и быт» — доля аренды и коммунальных услуг, питание, одежда: 22, 30 или 38 тыс. ₽ в месяц (оптимистичный, базовый, пессимистичный случай). Это допущения, а не данные. Цена часа — 350, 475 или 600 ₽. Сравнивается с 44,8 тыс. ₽ за место в ПНИ.

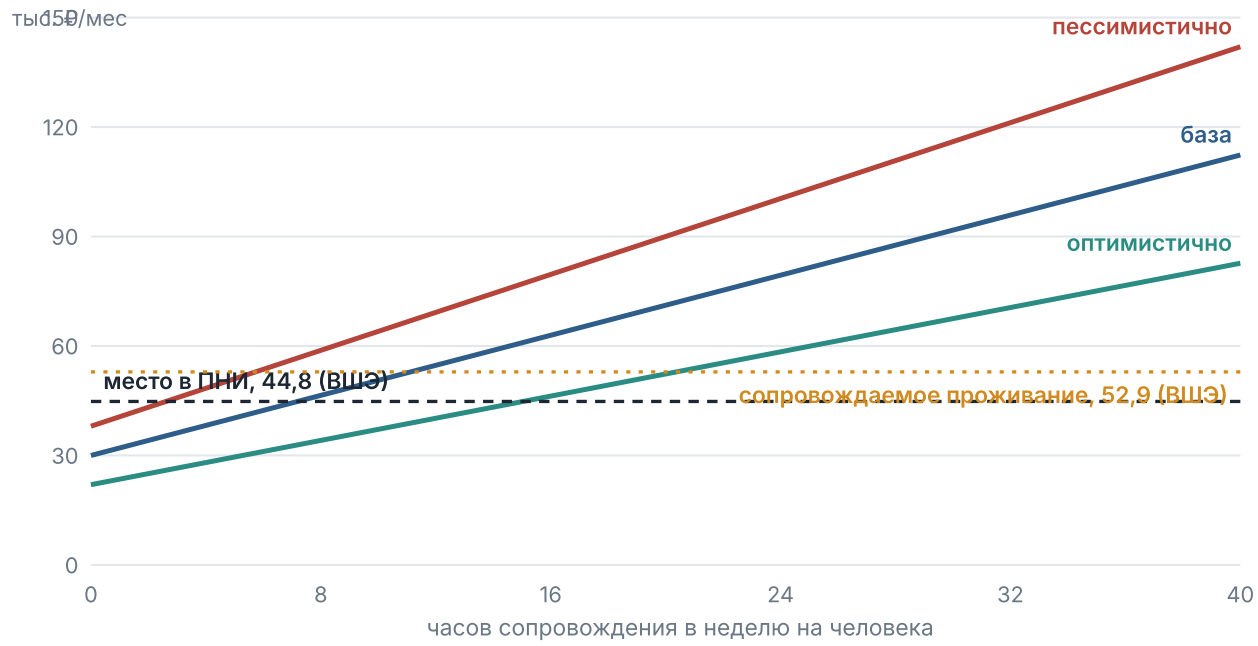


Рисунок 7.1. Полная стоимость жизни в квартире в зависимости от числа часов сопровождения (модель автора) в сравнении с данными ВШЭ.

Таблица 7.2. Результат модели, тыс. ₽ в месяц на человека (ПНИ = 44,8)

Часов в неделю	Оптимистично	База	Пессимистично
6	31,1	42,4	53,6
12	40,2	54,7	69,2
24	58,4	79,4	100,4
40	82,7	112,3	142,0
Точка безубыточности	15 ч/нед	7 ч/нед	3 ч/нед

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦУ

Таблица не предсказывает цены. Она показывает чувствительность. Если жильё и быт обходятся дёшево, а час сопровождения стоит недорого, сопровождение до 15 часов в неделю дешевле места в ПНИ. Если дорого — не дешевле даже на 3 часах. Знак разницы зависит от двух чисел, которые есть у каждого региона: тарифа часа и стоимости жилья. Это и есть причина, по которой прежний вывод «в четыре раза дешевле» был некорректным: он опирался на цифры, не относившиеся к текущим расходам.

В модели сопровождение считается индивидуальным. В квартире на 3–4 человека часть времени специалиста делят между жителями, ночное присутствие — одно на группу; это снижает цену на человека, но в модель не заложено.

7.3. Условный регион N

ПНИ на 400 мест. Годовые текущие расходы: 400 × 44,8 тыс. ₽ × 12 = **215 млн ₽**. Допустим, как в Нижегородской области, у 20 % жителей (80 человек) потребность не превышает 12 часов в неделю; это допущение для иллюстрации, долю нужно измерить.

Таблица 7.3. Что меняется, если перевести 80 человек с лёгкой потребностью в квартиры (разница с ПНИ, млн ₽ в год)

Допущение	Квартира, тыс. ₽/мес на человека	Разница на 80 человек
Оптимистично (350 ₽/час, жильё и быт 22)	40,2	−4,4
База (475 ₽/час, 30)	54,7	+9,5
Пессимистично (600 ₽/час, 38)	69,2	+23,4

Дополнительно, если перевести ещё около 100 человек (всего 45 %) в групповое сопровождаемое проживание по средней цене ВШЭ 52,9 тыс. ₽, это +9,7 млн ₽ в год к месту в ПНИ; при московской цене 111,9 — +80,5 млн ₽.

> **ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ РАСЧЁТ**
>
> - Экономия от перехода не гарантирована. Она возможна при дешёвом жилье, невысокой цене часа и действительно лёгкой потребности.
> - Переход меняет структуру: часть затрат переходит на жильё, часть — на людей, которые проводят время с человеком, а не на содержание зданий и круглосуточных постов.
> - Если освободившиеся места пополняются из очереди (98,6 % заполнения, 2,8 тыс. человек в очереди, 6 тысяч ждут сопровождаемого проживания [1]), общие расходы не падают. Тогда реформа увеличивает охват, а не сокращает бюджет. Это хорошая новость для людей и неприятная для Минфина: Минфин должен знать это заранее.
> - Обязательно закладывается переходный фонд на период двойного финансирования, 2–3 года [16].

7.4. Что можно посчитать самостоятельно

1. Стоимость места в вашем ПНИ: полная смета делится на число жителей. Включите питание, медицину, коммуналку, административные расходы, капитальный ремонт.
2. Долю жителей по часам потребности (обследование).
3. Тариф часа сопровождения в вашем регионе (зарплата специалиста с налогами, транспорт, администрирование).
4. Стоимость аренды или социального найма квартиры на 3–4 человека и коммунальные услуги.
5. Размер платы жителя за проживание в ПНИ и в квартире.

6. Размер переходного фонда: места, которые ещё оплачены, плюс квартиры, которые уже открыты.

7.5. Где взять деньги

Таблица 7.4. Механизмы финансирования

Механизм	Где применяют	Оговорка
Перенаправление части бюджета со «статьи ПНИ» на «статью сопровождения»	Бразилия: расходы на внебольничную помощь превысили больничные с 2006 года [26]	Работает, если потеряна часть мест, иначе увеличивается общий бюджет
Дополнительный перечень социальных услуг	Ленинградская область: 14 услуг [8]	Услуга, которой нет в перечне, не финансируется
Субсидия работодателю за рабочее место	Ленинградская область: до 500 тыс. ₽ [8]	Из существующих линий поддержки занятости
Внебюджетное финансирование под результат	Якутия: проект с ВЭБ.РФ [33]. Англия: Golden Lane Housing, 21 млн £†	В России итоги подобных проектов в этой версии не подтверждены
Федеральные субсидии «Доступная среда»	С 2019 года [8]	Размер регионального доступа нужно уточнять
Совместные расчёты с соседними бюджетами (здравоохранение, МВД)	Финляндия, США (идея)	Требует данных о вызовах скорой, днях в больнице и полицейских эпизодах до и после

ЧАСТЬ 8

План региона и вопросы к самим себе

8.1. Дорожная карта: пять шагов

Шаг	Что делать	Срок
1. Обследование	Междисциплинарная оценка всех жителей ПНИ: потребность в часах, навыки, жильё, семья, дееспособность. Разделить на когорты: лёгкая (до 12 часов в неделю), средняя, тяжёлая. Метод — нижегородский [8].	3–6 месяцев
2. Расчёт	Посчитать по таблицам части 7 на своих тарифах. Определить, где рост охвата, а где экономия, и какой нужен переходный фонд.	1–2 месяца
3. Документы	Региональный порядок сопровождаемого проживания (с учётом постановления № 910 и приказа № 85), перечень услуг, норматив «на человека», порядок учебных квартир, субсидия работодателю.	6–12 месяцев
4. Первая волна	15–30 человек из лёгкой когорты; учебная квартира → постоянное проживание; первые рабочие места. Метрики: индекс качества жизни, цена на человека, вызовы скорой, возвраты в ПНИ.	год 1–2
5. Масштаб	Перепрофилирование корпусов в малые дома, жилищный фонд, подготовка кейс-менеджеров. Цели по размеру групп (3–4) и по числу людей вне ПНИ.	год 2–5

8.2. Что можно сделать без новых денег

1. Назначить ответственного за сопровождаемое проживание на уровне заместителя руководителя, с календарём работ.
2. Открыть интернат для внешних глаз: дни семей, волонтёры, публичная страница, независимые визиты. По сообщению «Ведомостей», открытие ПНИ для волонтёров в Нижегородской области снизило число нарушений [2].
3. Пересадить жителей по биографиям и укладу, а не только по диагнозам, в уже имеющихся комнатах.
4. Заменить часть «обслуживания» на обучение: готовка, бюджет, транспорт, как в тренировочных квартирах.
5. Включить в обследование вопрос о возможности восстановления или изменения статуса дееспособности.
6. Найти первую квартиру: муниципальный фонд, служебное жильё, договор социального найма.
7. Запросить документы у Нижегородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга, а не писать свои с нуля.

8. Включить в договоры с опекунами и семьями право на посещения и информацию.

8.3. Вопросы, которые стоит задать до начала

- Что будет с освободившимися местами: закроем или заполним из очереди? От ответа зависит, будет ли экономия.
- Кто будет нести ответственность за человека вне стен: опекун-директор или кто-то ещё?
- Какой размер группы мы считаем нормой? Если больше 4 — зачем?
- Что мы измеряем: число переведённых или то, как они живут через год?
- Что подхватит расходы на третий год, когда закончится пилот?
- Кто снаружи видит, что происходит внутри?

8.4. Метрики для отчёта

Метрика	Как мерить
Число людей вне ПНИ через 12 месяцев	Постоянное проживание, не учебное
Возвраты в ПНИ	Доля вернувшихся за первый и второй годы
Качество жизни	Индекс по критериям ВОЗ (методика ВШЭ), до и после
Цена на человека	Полная стоимость, включая жильё и быт, а не только сопровождение
Размер групп	Среднее и максимум по квартирам
Занятость	Работа на открытом рынке, а не в мастерских при учреждении
Безопасность	Вызовы скорой, экстренные госпитализации, жалобы, смерти

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Глоссарий

Термин	Значение
Долговременный уход (LTC)	Всё, что нужно человеку, не справляющемуся с бытом из-за состояния здоровья: помощь с едой, гигиеной, жильём, передвижением, общением.
Деинституционализация	Переход от больших учреждений к жизни в обычном жилье с поддержкой. Не закрытие здания, а перенос услуги к человеку.
Сопровождаемое проживание	Российская форма поддержки жизни в квартире или малой группе по индивидуальному плану; закреплено в ст. 9.1 181-ФЗ.
Учебное сопровождаемое проживание	Временное обучение навыкам, часто на территории ПНИ.
Housing First	Постоянное жильё без предварительных условий; поддержка подключается следом.
Reablement	Короткая интенсивная программа восстановления бытовой автономии (в Дании 3–12 недель).
Персональный бюджет, прямые выплаты	Деньги идут человеку, который сам нанимает помощников (Англия — direct payments, Германия — Pflegegeld).
Распределённая опека	Возможность иметь нескольких опекунов, не только директора интерната. Законопроект отклонён в феврале 2025.
Двойное финансирование (double running)	Период, когда оплачиваются и старая система, и новая; обычно 2–3 года.
Кейс-менеджер	Специалист, собирающий для человека пакет услуг (Япония).
Трансинституционализация	Ложная деинституционализация: человек покидает интернат, но оказывается в другой закрытой структуре (тюрьма, ночлежка, частный пансион без контроля).
СДУ	Система долговременного ухода — федеральная система для пожилых и людей с инвалидностью.
ИППСУ	Индивидуальная программа предоставления социальных услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Журнал исправлений

Что изменено по сравнению с версией 2 и почему.

№	Было	Стало и причина
1	ПНИ стоит 8–24 тыс. ₽ в месяц; сопровождаемое проживание 2–6 тыс. ₽; «в 4 раза дешевле»	Текущие расходы по ВШЭ: 44,8 и 52,9 тыс. ₽. Диапазоны 8–24 и 2–6 — капитальные затраты по пересказу «Если быть точным». Тезис «дешевле в 4 раза» снят.
2	Регион N: экономия 35–38 %; «датская норма снимает дилемму»	База расчёта (16 тыс. ₽) была неверной, а пенсия, меняющая плательщика, не уменьшает полную стоимость. Заменено моделью с чувствительностью (часть 7).
3	В ПНИ 160–220 тыс. жителей; потенциал 70–100 тыс.	139 тыс. (2024) по «Если быть точным»; 174 тыс. по Минтруду в отделениях всех организаций. Потенциал 45 % — около 63 тыс.
4	«Менее 1 774 человек в 214 квартирах»	Уточнено: не более 1,8 тыс. на постоянном проживании; Минтруд считает около 7 тыс. вместе с учебным.
5	Пилот Минтруда «завершается в 2025 году»	Устарело. Добавлены приказ № 85 (2025), отклонение закона о распределённой опеке (2025), СДУ, строительство новых ПНИ.
6	Хогевейк: «жители активнее и получают меньше лекарств»	CADTH не нашёл независимых оценок; утверждение снято.
7	Финляндия — «единственная страна ЕС, где бездомность сокращается»	В 2024 году первый рост после 11 лет снижения (3 806, +377).
8	Бразилия: 24,8 % → 79,4 %	Подтверждено другое: 95,5 % → 49 % (1995–2005), перевес внебольничных расходов с 2006 г., 79,39 % в 2013 г. по обзору.
9	Германия: 63,3 млрд € (2024)	Добавлены данные 2025 (73,8 млрд €), взнос 3,6 %, кредиты; 63,3 помечено †.
10	Региональные кейсы: Челябинск (ВЭБ.РФ/РМК), Тюмень, ХМАО, Курган, ЯНАО, Москва	Не подтверждены, убраны (приложение В). Добавлены проверенные: Петербург, Якутия, Ярославская область.
11	Курсы валют и пересчёты в рубли	Убраны: курсы менялись, пересчёты создавали ложную точность. Суммы даны в национальной валюте.
12	Опечатки и сбои текста («Кремлёв… то есть…», «навук», дубли номеров страниц)	Исправлено.
13	Лозунги и риторические обороты («самый ценный кейс», «Осталось применить»)	Убраны; текст сокращён и приведён к фактам.
14	Нет раздела о доказательной базе по затратам	Добавлена часть 3: DECLOC (2007), обзор BMJ Open (2019), опыт ЕС.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Что не удалось проверить

Эти утверждения были в версии 2. При проверке подтверждения не найдено; они удалены из основного текста. Это не значит, что они неверны. Перед использованием нужно искать первоисточник.

- Челябинская область: проект социального воздействия с ВЭБ.РФ и РМК, 16 человек перешли на самостоятельное проживание, 8 остались в семьях.
- Тюменская область: дорожная карта 2020–2024, «3D-квартира», рост охвата 65 → 75 человек.
- ХМАО: Излучинский дом-интернат, модельная программа для возраста 18–55.
- Курганская область: Галишевский ПНИ, отделение на 14 мест.
- ЯНАО: постановление № 1064-П (2021).
- Москва: сокращение коечного фонда с 118 до 62 на 100 тыс.
- Свердловская область: пекарня при доме в Верх-Нейвинском; тренировочные квартиры (конкретные данные).
- Триест / Италия: «19 000 мест в малых защищённых резиденциях» и «4 500+ социальных кооперативов» (общеитальянские показатели, а не Триеста).
- США: «31 000 $ за год в тюрьме против 10 000 $ в сообществе»; «650 млн $ в год в Техасе».
- Греция: конкретные суммы в драхмах и доли довольных жителей после ухода итальянской команды.
- Постановление об отмене удержания 75 % заработной платы «30 октября 2021»: подтверждена лишь общая норма исключения зарплаты из расчёта дохода (дата не указана).
- Приказ Минтруда № 85: балльная шкала «23–272 балла» и «четыре степени нарушения автономии» упомянута в одной публикации, текста приказа с этими числами не найдено.
- Исходный отчёт ВШЭ (2021–2022): сверить трактовку диапазонов 8–24 и 2–6 тыс. ₽.
- Статья 31 442-ФЗ — точная формулировка предела платы (75 % среднедушевого дохода).

Метка † в тексте означает цифры, перенесённые из версии 2 с указанным источником, которые в этой версии не перепроверялись: немецкие показатели Министерства здравоохранения, британские цены Mencap/Housing LIN, число домов Хогевейка, пилот Housing First 14 980 €, показатели Nuffield Trust по Дании и Швеции, число заключённых с психическими расстройствами в США, Лерос, Golden Lane Housing 21 млн £, ¥11,2 трлн в Японии.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Источники

1. «Если быть точным». Как устроены ПНИ в России. tochno.st
2. «Ведомости», 10.04.2026. Психоневрологических интернатов за три года стало на 13 % меньше. vedomosti.ru
3. «Медуза», 14.04.2026 (проект «Если быть точным»). meduza.io
4. Vademec, 10.04.2026. Программа сопровождаемого проживания в РФ охватывает менее 1,8 тысячи человек. vademec.ru
5. АСИ, 22.12.2022. Развитие сопровождаемого проживания не только гуманно, но и экономически выгодно — считают в ВШЭ. asi.org.ru
6. «Милосердие.ру». Качество жизни инвалидов на сопровождаемом проживании выше, чем в ПНИ, подтвердило исследование. miloserdie.ru
7. «Известия», 24.05.2026. Эксперт объяснил выгоду сопровождаемого проживания по сравнению с ПНИ. iz.ru
8. АСИ, 18.11.2024. Сопровождаемое проживание: опыт регионов и точки роста. asi.org.ru
9. АСИ, 21.07.2026. В России долговременным уходом охвачено 11 % пожилых и людей с инвалидностью. asi.org.ru
10. «Ведомости», 20.07.2026. Только 11 % нуждающихся охвачены уходом; Парламентская газета (сенатор Мельникова, 31,5 млрд ₽ на 2026 год). vedomosti.ru
11. Федеральный закон № 137-ФЗ от 28.04.2023; постановление Правительства № 910 от 03.07.2024. Правовой навигатор; Варта-24; Контур.Норматив
12. Приказ Минтруда № 85 от 25.02.2025. ppt.ru
13. Vademec, 14.02.2025. Госдума отклонила законопроект о распределённой опеке. vademec.ru
14. Парламентская газета. Работающие в интернатах инвалиды смогут сохранить больше доходов. pnp.ru
15. E1.ru, 08.02.2021. В уральском посёлке обустроят дом для людей из интернатов, которые хотят жить самостоятельно. e1.ru
16. Mansell J., Knapp M., Beadle-Brown J., Beecham J. (2007). Deinstitutionalisation and community living — outcomes and costs. Tizard Centre, University of Kent. research.kent.ac.uk
17. May P. et al. (2019). Effect of deinstitutionalisation for adults with intellectual disabilities on costs: a systematic review. BMJ Open 9:e025736. PMC6756329
18. ENIL, EU Funds and Independent Living (2018); European Coalition for Community Living (2010), Wasted time, wasted money, wasted lives…; ENIL, shadow report (2025). enil.eu
19. OECD (2023). Health at a Glance 2023, long-term care spending and unit costs. oecd.org
20. GKV-Spitzenverband / dpa (01.03.2026), Pflegeversicherung 2025. gkv-spitzenverband.de
21. NWB Experten-Blog. Gesetzliche Pflegeversicherungsbeiträge steigen ab 1.1.2025. nwb-experten-blog.de
22. DHSC (2025). Adult social care finance report, England: 2024 to 2025. gov.uk
23. CADTH (2020). Dementia Villages: Innovative Residential Care for People with Dementia. cadth.ca
24. Y-Säätiö (10.02.2025). Homelessness on the rise in Finland; ARA, статистика бездомности. ysaatio.fi
25. Mental Health Commission of Canada. At Home/Chez Soi, итоговый отчёт. mentalhealthcommission.ca
26. Бразильские исследования реформы: Cadernos de Saúde Pública; Ciência & Saúde Coletiva; Ministério da Saúde, Saúde Mental em Dados
27. Mental Health Care in Japan (обзор, данные MHLW Hospital Report 2018). mjphm.org.my
28. KEIA, Improving Korea's Long-Term Care for the Elderly; LTCcovid, Republic of Korea. keia.org; ltccovid.org
29. Комитет ООН по правам инвалидов (2022). Guidelines on deinstitutionalization, including in emergencies. digitallibrary.un.org
30. Описания системы Триеста: Australian Senate, Report of mental health services observed in Trieste (2006) aph.gov.au; R. Mezzina, презентация (2012) sfcommunityliving.org
31. Leigh Day. Winterbourne View timeline since 2011. leighday.co.uk
32. «Новостройки»: Топилин — для инвалидов и пожилых больше не будут строить казармы (40 млрд ₽). novostroy.ru (дата публикации не установлена)

33. ГАООРДИ: проект с ВЭБ.РФ в Якутии. vk.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Как повторить расчёты

В репозитории лежит папка `report/src`. В ней:

- `calc.py` — все формулы и допущения в одном месте. Запуск `python3 calc.py` печатает таблицы 7.1–7.3. Допущения (цена часа, стоимость жилья и быта) находятся вверху файла.
- `figures.py` — строит графики из тех же чисел.
- `report.html` — текст доклада. `build.sh` собирает PDF через Chromium.

Оценка расходов России на долговременный уход (0,1–0,2 % ВВП) перенесена из версии 2 без пересчёта (метка †). Единой статистики по этой статье нет, поэтому её нужно переделать по официальной отчётности Минтруда и региональным бюджетам.